BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHẬT TÂN Phòng Điều dưỡng	QUY TRÌNH CHUẨN (SOP) PHỐI HỢP ĐA CHUYÊN KHOA TRONG CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH	Mã số: SOP-C6.3-02 Lần ban hành: 01 Ngày hiệu lực: …/…/2026 Số trang: theo bản in

	Người biên soạn	Người kiểm tra	Người phê duyệt
Họ tên			
Chức danh	Điều dưỡng Phòng Điều dưỡng	Trưởng phòng Điều dưỡng	Giám đốc
Chữ ký			
Ngày			

Lần	Ngày	Nội dung sửa đổi
01		Ban hành lần đầu

DỰ THẢO

1. Mục đích

Bảo đảm người bệnh có nhu cầu chăm sóc vượt quá phạm vi điều dưỡng được phối hợp kịp thời với các chuyên khoa liên quan, có ghi nhận và theo dõi kết quả.

2. Phạm vi áp dụng

Người bệnh nội trú tại các khoa lâm sàng; các đơn vị phối hợp: Tổ dinh dưỡng, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng, Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Khoa Dược, bác sĩ chuyên khoa.

3. Trách nhiệm

- ĐD được phân công: phát hiện tình huống cần phối hợp, báo bác sĩ, ghi nhận.
- Bác sĩ điều trị: chỉ định hội chẩn hoặc phối hợp chuyên khoa.
- Đơn vị phối hợp: tiếp nhận, đánh giá, can thiệp trong thời hạn quy định, ghi kết quả.
- ĐDT khoa: theo dõi việc phối hợp, tổ chức trao đổi chăm sóc liên chuyên khoa cho NB Cấp I nằm viện trên 7 ngày hoặc có ≥ 2 nguy cơ cao.

4. Nội dung quy trình

Tình huống	Đơn vị phối hợp	Thời hạn	Ghi nhận
Sàng lọc dinh dưỡng dương tính; nuôi ăn qua ống thông	Tổ dinh dưỡng – tiết chế	Trong 24 giờ	Phiếu đánh giá dinh dưỡng; phiếu chăm sóc
NB hạn chế vận động, sau tai biến, sau mổ chỉnh hình, nguy cơ loét cao	Khoa YHCT – PHCN	Trong 48 giờ	Phiếu chỉ định PHCN; phiếu chăm sóc

Tình huống	Đơn vị phối hợp	Thời hạn	Ghi nhận
NB có catheter, ống thông, vết thương nhiễm khuẩn, cần cách ly	Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn	Trong ca phát hiện	Phiếu giám sát KSNK
NB dùng thuốc nguy cơ cao; nghi phản ứng có hại của thuốc	Khoa Dược (dược lâm sàng)	Ngay khi phát hiện	Phiếu báo cáo ADR; phiếu chăm sóc
NB lo âu, trầm cảm, có nguy cơ tự gây hại	Bác sĩ điều trị, chuyên khoa liên quan	Ngay	HSBA; báo cáo sự cố nếu có

Các bước:

1. ĐD phát hiện tình huống cần phối hợp khi nhận định, đánh giá nguy cơ hoặc theo dõi hằng ngày; đánh dấu mục "Phối hợp" trên BM-C6.3-01.
2. Báo bác sĩ điều trị; bác sĩ chỉ định phối hợp (ghi HSBA).
3. ĐD liên hệ đơn vị phối hợp (điện thoại, phiếu yêu cầu); ghi thời điểm liên hệ.
4. Đơn vị phối hợp đánh giá, can thiệp trong thời hạn quy định, ghi kết quả.
5. ĐD cập nhật can thiệp phối hợp vào kế hoạch chăm sóc BM-C6.3-02, lượng giá hiệu quả.
6. NB Cấp I nằm viện trên 7 ngày hoặc có ≥ 2 nguy cơ cao: ĐDT tổ chức trao đổi chăm sóc liên chuyên khoa (có thể lồng vào giao ban khoa), ghi biên bản ngắn.

5. Tiêu chuẩn đánh giá

- ≥ 85% NB có chỉ định phối hợp được phối hợp đúng hạn (KPI-C6.3-10).
- ≥ 90% NB sàng lọc dinh dưỡng dương tính được can thiệp (KPI-C6.3-07).

6. Hồ sơ

- Phiếu chăm sóc, BM-C6.3-01, BM-C6.3-02 (lưu trong HSBA).
- Biên bản trao đổi chăm sóc liên chuyên khoa (lưu tại khoa, 03 năm).
- BM-C6.3-03 mục 14 (giám sát việc phối hợp).

7. Tài liệu tham khảo, căn cứ

- Thông tư số 31/2021/TT-BYT quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện.
- Thông tư số 32/2023/TT-BYT, Phụ lục XII được sửa đổi bởi Thông tư số 25/2026/TT-BYT.
- Thông tư số 18/2020/TT-BYT quy định về hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện.
- Thông tư số 43/2018/TT-BYT hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa.
- Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 (Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam).
- Quy định chăm sóc người bệnh toàn diện QĐ-C6.3; SOP-C6.3-01.